



Unidade Didáctica 3

Avaliação clínica e laboratorial de utentes em PrEP

No final desta unidade os participantes deverão ser capazes de:

- Descrever as principais considerações gerais para a implementação da PrEP.
- Explicar a visão geral do percurso de avaliação da PrEP.
- Explicar o processo de rastreio da infecção aguda pelo HIV.
- Explicar o processo de rastreio e tratamento de ITS.
- Explicar o Algoritmo Da Avaliação Da Função Renal
- Descrever os elementos do aconselhamento no âmbito da PrEP (prevenção e antes de iniciar a PrEP).

No final desta unidade os participantes deverão ser capazes de:

- Indicar os regimes de PrEP aprovados em Moçambique.
- Listar as contraindicações para a PrEP.
- Descrever os efeitos colaterais da PrEP.
- Explicar como manejar os possíveis efeitos colaterais da PrEP.
- Especificar os procedimentos para a visita inicial e de seguimento da PrEP.
- Descrever os fundamentos e conteúdo para aconselhamento, durante a visita inicial e de seguimento para PrEP.
- Descrever os fundamentos e conteúdo para aconselhamento, durante a visita inicial e de seguimento para PrEP.

Considerações gerais para a implementação da PrEP (1)

- Ao planificar a implementação de serviços para a oferta da PrEP nas unidades sanitárias, deve-se ter em consideração quatro aspectos importantes:
 - Disponibilidade de medicamentos para a oferta aos utentes.
 - **Quem:** Recursos humanos capacitados para prover os serviços.
 - **Onde:** Portas de entrada onde serão oferecidos os serviços da PrEP nas Unidades Sanitárias.
 - **Como:** Avaliação clínica e laboratorial, fluxos de encaminhamento entre as diferentes portas e a modalidade de implementação.

Considerações gerais para a implementação da PrEP (2)

Quem ?	Onde? (Rastreio para a elegibilidade)	Onde ? (Oferta da PrEP)
• Médicos • Técnicos de Medicina Geral • Enfermeira de SMI • Enfermeiros gerais • Psicólogos • Técnico de Psiquiatria • Técnicos de laboratório • Técnicos de farmácia • Conselheiros leigos	• UATS • SMI (CPN, CCR, CPF, CPP, CCS) • SAAJ • Consulta de Doenças Crónicas • Consultas Integradas • Triagem Adulto • Consultas Externas	• SMI (CPN, PF) • SAAJ • Consulta de Doenças Crónicas • Consultas Integradas • Triagem Adulto • Consultas Externas

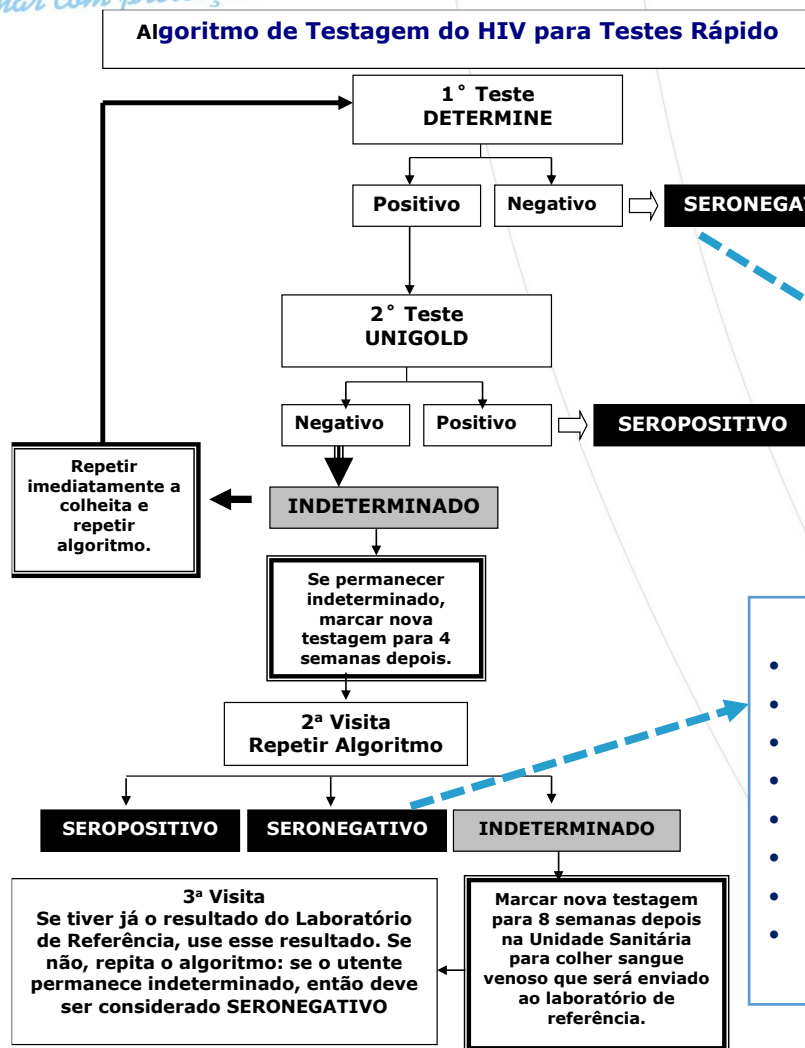
Considerações gerais para a implementação da PrEP (3)

- Todos os provedores devem ser capacitados de acordo com as suas competências no pacote completo de intervenções para oferta desta abordagem.
- Os provedores clínicos destes gabinetes (**Paragem Única da PrEP**) devem oferecer a PrEP seguindo a escala de rotatividade elaborada pela US.
- A US deve identificar um Ponto Focal da PrEP, responsável pela coordenação das actividades

- A PrEP deve ser **integrado nos sectores e serviços** já existentes na Unidade Sanitária (SMI -CPN/CPF/CCR , SAAJ, Doenças Crónicas, Consulta Integrada, Triagem de adulto, Consulta Externa).
- O pacote de serviços para a PrEP deve ser **oferecido** na modalidade de paragem única pois:
 - É centrada no paciente.
 - Reduz o tempo de espera do paciente na US.
 - Facilita a criação de vínculo com os provedores.
 - Reduz o estigma melhorando a adesão.
 - Melhora o seguimento clínico e laboratorial.
 - Reduz a discrepância de dados entre as fontes.
 - Facilita a gestão do estoque de medicamentos.

- Na paragem única da PrEP abre-se a ficha de seguimento do utente, dispensa do medicamento e colheita da amostra de sangue para os exames laboratoriais.
- Onde não for possível colher a amostra na paragem única, os utentes são referidos para o laboratório para a colheita de amostras de sangue para os exames laboratoriais
- Nas US com várias portas de atendimento ex: **consulta externa, triagem, doença crónica, etc.** Deve-se identificar um único gabinete para oferta da PrEP.

Visão geral do percurso de avaliação da PrEP



Prevenção Combinada do HIV

- Preservativos
- **PrEP oral**
- Aconselhamento
- PPE
- Estilos de vida saudáveis
- Tratamento das ITS
- CMMV
- TARV para parceiros que vivem com o HIV

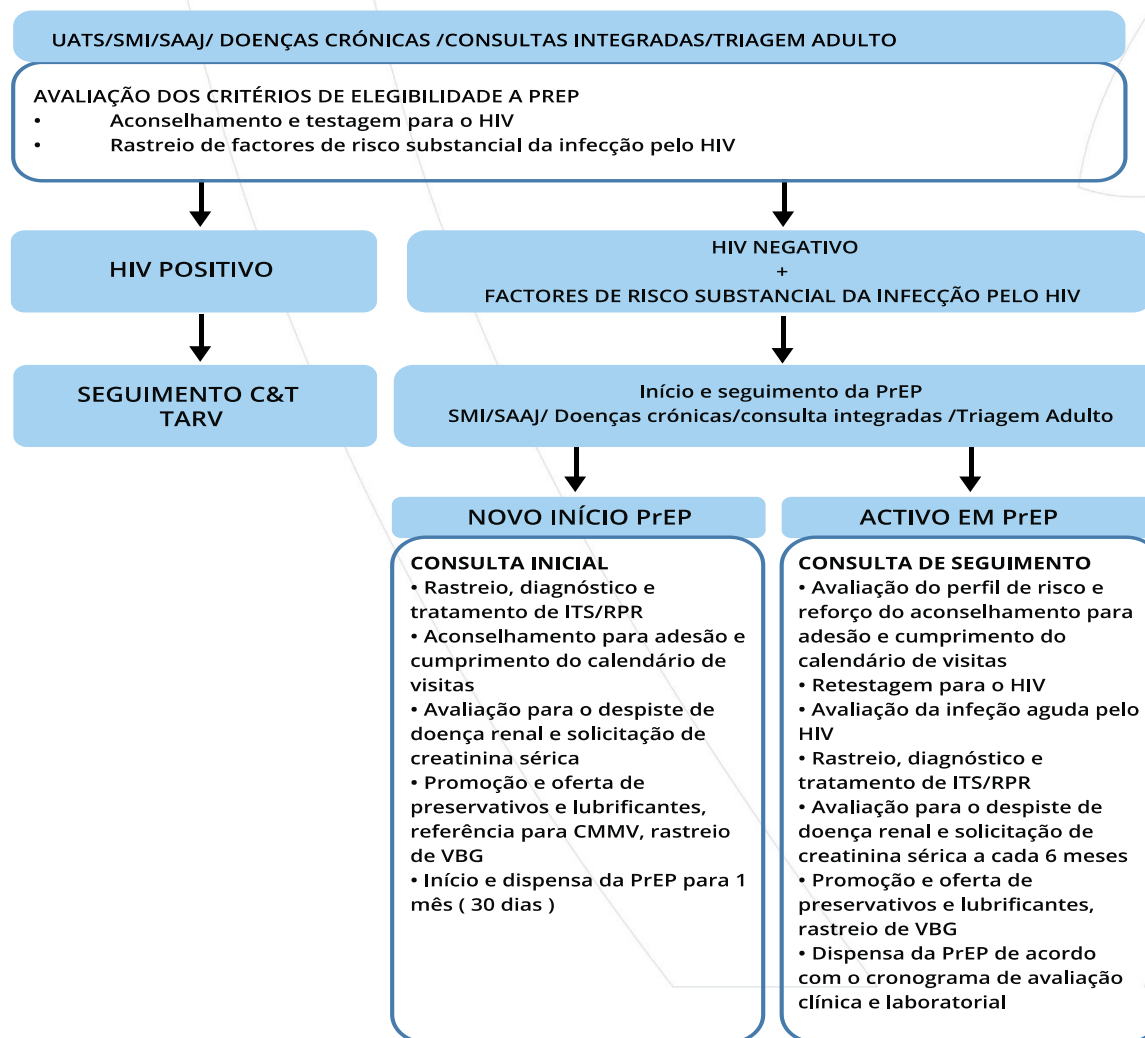
1. Avaliação da elegibilidade
2. Início da PrEP
3. Seguimento

Visão geral do percurso de avaliação da PrEP

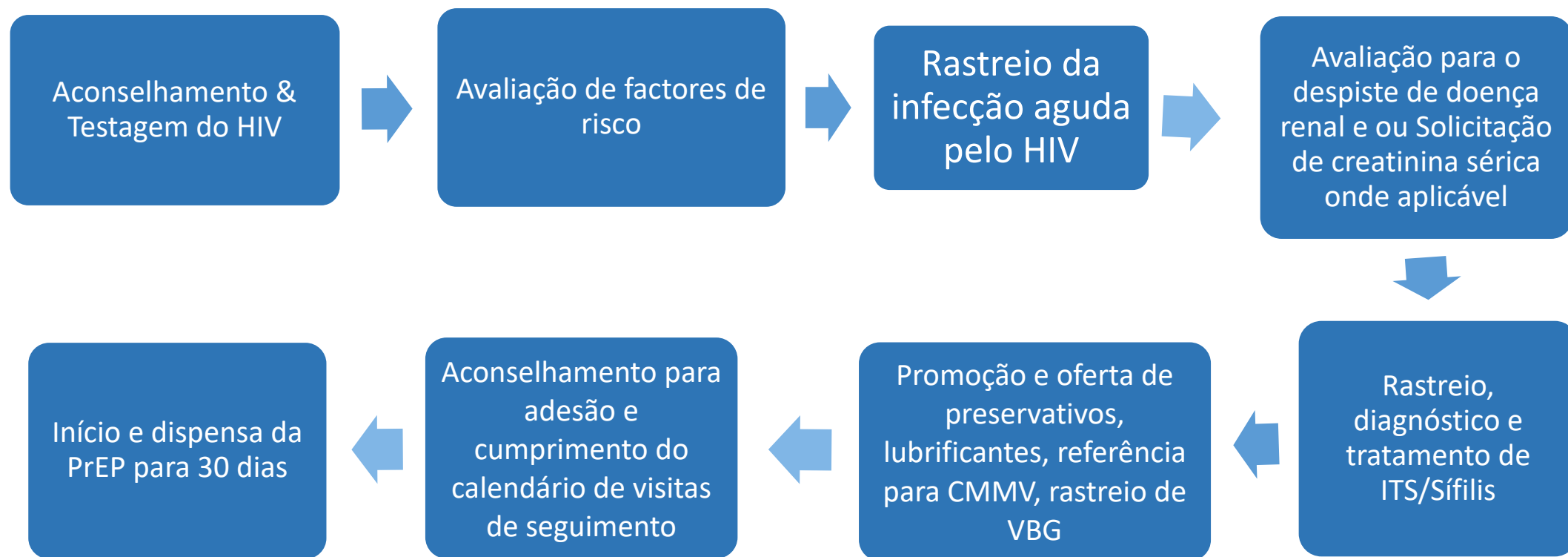


República de Moçambique
Direcção Nacional de Saúde Pública - Ministério da Saúde
Programa Nacional de Controle das ITS, HIV/SIDA

Algoritmo de início e seguimento de utentes em PrEP nas Unidades Sanitárias



Consulta inicial da PrEP



Investigações de linha de base para iniciar a PrEP

RASTREIO	MÉTODO
Infecção pelo HIV	Testagem Rápida do HIV
Avaliação da função Renal	Algoritmo da avaliação da Função Renal Creatinina - GFR > 60mL/min
Rastreio da Hepatite B (VHB)	Antigénio de superfície (HBsAg)
Rastreio de ITS	Rastreio sintomático Exame físico Rastreio serológico para a sífilis (rápido ou laboratorial) Testes rápidos de ITS se possível
Rastreio de gravidez	DUM, Teste rápido de gravidez ou beta HCG

Rastreio da infecção aguda pelo HIV

- Testagem rápida do HIV no dia da consulta inicial para a PrEP oral.
- Avaliar para infecção aguda pelo HIV (sinais e sintomas).
- Suspeito de infecção aguda pelo HIV
- Adiamento do início da PrEP (2-4 semanas)
- Reteste com teste rápido de HIV após 2-4 semanas se os sintomas desaparecerem



Rastreio e tratamento das ITS (1)

- A PrEP constitui uma oportunidade para identificar pessoas em alto risco de infecção pelo HIV e ITS.
- Assim como para otimizar a oferta de **pacote mínimo de serviços para a prevenção e controlo das ITS.**
- A PrEP confere protecção contra a infecção pelo HIV com uma eficácia acima de 90%.

ATENÇÃO!

Não previne contra as outras ITS como: **Clamídia, Gonorreia e Sífilis**, sendo o uso do **preservativo o método mais eficaz para prevenção da maioria das ITS.**

- O rastreio das ITS deve ser feito a cada consulta de modo a diagnosticar e tratar os casos atempadamente, de acordo com os algoritmos nacionais.
- Rastreio das ITS :
 - História
 - Exame Físico
 - Teste plasma de RPR
 - Teste de Chlamydia trachomatis (CT) e Neisseria gonorrhoeae (NG) se os recursos o permitirem
 - Oferta do pacote mínimo de serviços para a prevenção e controlo das ITS

Pacote mínimo de serviços para a prevenção e controlo das ITS consiste na :

- Redução do risco de infecção através de informação, educação e comunicação.
- Aconselhamento e testagem em saúde a todos os pacientes e contactos com ITS.
- Rastreio e diagnóstico de ITS a todos os pacientes HIV+ em todas as consultas.
- Tratamento para os casos de ITS.
- Rastreio e tratamento correcto da sífilis a toda a mulher grávida.
- Convidar o parceiro para rastreio precoce e tratamento.
- Oferta de preservativos e promoção do seu uso adequado e consistente.

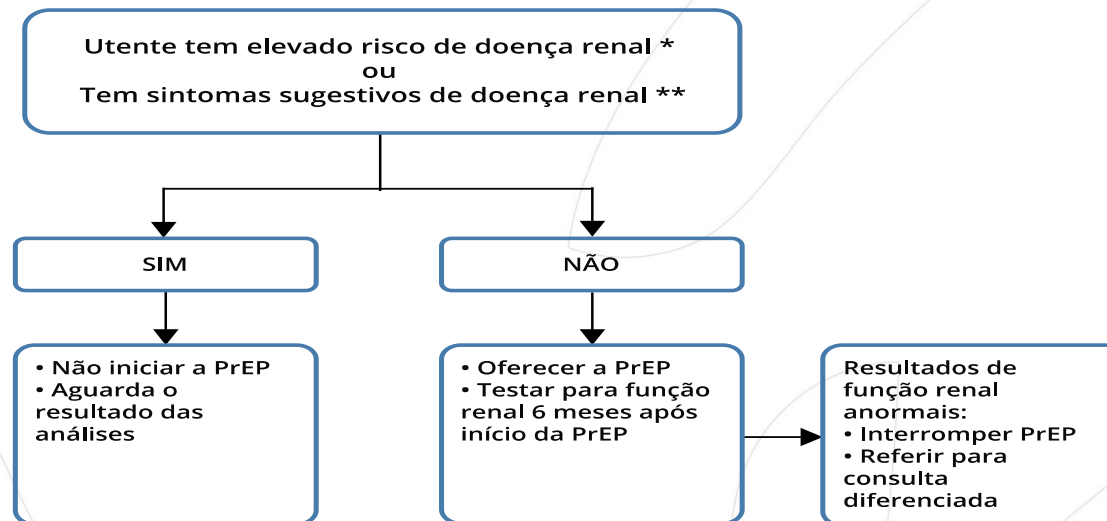
Avaliação da função renal (1)



República de Moçambique

Direcção Nacional de Saúde Pública - Ministério da Saúde
Programa Nacional de Controle das ITS, HIV/SIDA

Algoritmo para o despiste de doença renal



*Grupos de elevado risco para doença renal crónica

- História familiar de doença renal
- Diabetes
- Hipertensão não controlada
- Infecções Urinárias recorrentes
- Síndrome de obstrução das vias urinárias
- Doença sistémica que afecta os rins
- Idade > 60 anos

**Sintomas sugestivos de doença renal

- Fadiga
- Insonia
- Pele seca e pruriginosa
- Poliúria
- Hematúria
- Urina espumosa
- Edema nos tornozelos e pés
- Edema dos olhos
- Cãimbras
- Náuseas e vômito

Atenção!

Onde for possível :

- Avaliação de creatinina deve ser realizada **apenas** para utentes com histórico de doença renal crónica OU que tenham > 30 anos.
- O resultado da monitoria da creatinine para estes utentes deve estar disponível entre 1 e 3 meses do início da PrEP.

Creatinina :

- Excreção por filtração glomerular e secreção tubular activa.
- Cálculo de depuração de creatinina $>60\text{mL/min}$ (Fórmula de Cockcroft- Gault).

Se $\text{CrCl} < 60 \text{ mL/min}$



Não iniciar PrEP oral



Repetir após 2 semanas;

Se normal, iniciar a PrEP

Se anormal, referir a consulta

Depuração de creatinina

- Fórmula de Cockcroft- Gault

Depuração da creatinina = $\frac{(140 - \text{idade}) * (\text{peso em kg})}{72 * \text{creatinina sérica em mg/dl}}$

(Sexo Masculino)

Depuração da creatinina = $\frac{(140 - \text{idade}) * (\text{peso em kg}) * 0.85}{72 * \text{creatinina sérica em mg/dl}}$

(Sexo Feminino)

- Cálculo aplicativo online

Creatinine Clearance Estimate by Cockcroft-Gault Equation [Share](#)

Input:

Sex ☒ Male (1) ☐ Female (0.85)

Age yr

Serum Creat mg/dL

Weight kg

Result:

Creat Clear mL/min

Decimal Precision: 2

Formula **Notes** **References**

$\text{CreatClear} = \text{Sex} * ((140 - \text{Age}) / (\text{SerumCreat})) * (\text{Weight} / 72)$

<http://reference.medscape.com/calculator/creatinine-clearance-cockcroft-gault>

Depuração de creatinina: Fórmula MDRD

Mulheres

Idade (anos)		Creatinina (mol/l) →															
	M	88.4	97.2	106.1	114.9	123.8	132.6	141.4	150.3	159.1	168.0	176.8	185.6	194.5	203.3	212.2	221.0
	15	99.4	88.3	78.1	71.2	65.4	60.4	56.0	52.2	48.9	45.9	43.3	40.9	38.8	36.9	35.1	33.5
	20	90.9	81.4	73.7	67.2	61.7	56.9	52.8	49.3	46.1	43.3	40.9	38.6	36.6	34.8	33.1	31.6
	25	86.9	77.8	70.4	64.2	58.9	54.4	50.5	47.1	44.1	41.4	39.0	36.9	35.0	33.2	31.6	30.2
	30	83.7	75.0	67.8	61.9	56.8	52.4	48.7	45.4	42.5	39.9	37.6	35.6	33.7	32.0	30.5	29.1
	35	81.1	72.7	65.7	59.9	55.0	50.8	47.2	44.0	41.2	38.7	36.5	34.5	32.7	31.0	29.5	28.2
	40	79.0	70.7	64.0	58.3	53.6	49.5	45.9	42.8	40.1	37.7	35.5	33.5	31.8	30.2	28.8	27.4
	42	78.2	70.1	63.4	57.8	53.0	49.0	45.5	42.4	39.7	37.3	35.1	33.2	31.5	29.9	28.5	27.2
	44	77.5	69.4	62.8	57.2	52.5	48.5	45.0	42.0	39.3	36.9	34.8	32.9	31.2	29.6	28.2	26.9
	46	76.8	68.8	62.2	56.7	52.1	48.1	44.6	41.6	39.0	36.6	34.5	32.6	30.9	29.4	28.0	26.7
	48	76.1	68.2	61.7	56.2	51.6	47.7	44.2	41.3	38.6	36.3	34.2	32.3	30.6	29.1	27.7	26.4
	52	74.9	67.1	60.7	55.3	50.8	46.9	43.5	40.6	38.0	35.7	33.6	31.8	30.1	28.6	27.3	26.0
	56	73.8	66.1	59.8	54.5	50.0	46.2	42.9	40.0	37.4	35.2	33.1	31.3	29.7	28.2	26.9	25.6
	58	73.2	65.6	59.3	54.1	49.7	45.9	42.6	39.7	37.2	34.9	32.9	31.1	29.5	28.0	26.7	25.4
	60	72.7	65.2	58.9	53.7	49.3	45.6	42.3	39.4	36.9	34.7	32.7	30.9	29.3	27.8	26.5	25.3
	62	72.3	64.7	58.5	53.4	49.0	45.3	42.0	39.2	36.7	34.4	32.5	30.7	29.1	27.6	26.3	25.1
	64	71.8	64.3	58.2	53.0	48.7	45.0	41.7	38.9	36.4	34.2	32.3	30.5	28.9	27.5	26.1	24.9
	66	71.3	63.9	57.8	52.7	48.4	44.7	41.5	38.7	36.2	34.0	32.1	30.3	28.7	27.3	26.0	24.8
	68	70.9	63.5	57.5	52.4	48.1	44.4	41.2	38.4	36.0	33.8	31.9	30.1	28.5	27.1	25.8	24.6
	70	70.5	63.2	57.1	52.1	47.8	44.2	41.0	38.2	35.8	33.6	31.7	29.9	28.4	27.0	25.7	24.5
	72	70.1	62.8	56.8	51.8	47.5	43.9	40.7	38.0	35.6	33.4	31.5	29.8	28.2	26.8	25.5	24.3
	74	69.7	62.4	56.5	51.5	47.3	43.7	40.5	37.8	35.4	33.2	31.3	29.6	28.1	26.7	25.4	24.2
	76	69.3	62.1	56.2	51.2	47.0	43.4	40.3	37.6	35.2	33.1	31.2	29.4	27.9	26.5	25.2	24.1
	78	69.0	61.8	55.9	50.9	46.8	43.2	40.1	37.4	35.0	32.9	31.0	29.3	27.8	26.4	25.1	24.0
	80	68.6	61.5	55.6	50.7	46.5	43.0	39.9	37.2	34.8	32.7	30.8	29.1	27.6	26.2	25.0	23.8

Homens

Idade (anos)	Creatinina (mol/l) →																
	H	88.4	97.2	106.1	114.9	123.8	132.6	141.4	150.3	159.1	168.0	176.8	185.6	194.5	203.3	212.2	221.0
↓	15	130	116	105	96	88	81	76	70	66	62	58	55	52	50	47	45
	20	123	110	99	91	83	77	71	66	62	58	55	52	49	47	45	43
	25	117	105	95	87	79	73	68	63	59	56	53	50	47	45	43	41
	30	113	101	91	83	77	71	66	61	57	54	51	48	45	43	41	39
	35	109	98	89	81	74	68	64	59	55	52	49	46	44	42	40	38
	40	106	95	86	79	72	67	62	58	54	51	48	45	43	41	39	37
	42	105	94	85	78	71	66	61	57	53	50	47	45	42	40	38	37
	44	104	94	85	77	71	65	61	57	53	50	47	44	42	40	38	36
	46	103	93	84	76	70	65	60	56	53	49	46	44	42	40	38	36
	48	103	92	83	76	70	64	60	56	52	49	46	44	41	39	37	36
	52	101	90	82	75	68	63	59	55	51	48	45	43	41	39	37	35
	56	99	89	81	73	67	62	58	54	50	47	45	42	40	38	36	35
	58	99	88	80	73	67	62	57	54	50	47	44	42	40	38	36	34
	60	98	88	79	72	66	61	57	53	50	47	44	42	39	37	36	34
	62	94	85	77	70	64	59	55	51	48	45	42	40	38	36	34	33
	64	97	87	78	71	66	61	56	52	49	46	43	41	39	37	35	34
66	96	86	78	71	65	60	56	52	49	46	43	41	39	37	35	33	
68	96	86	77	71	65	60	56	52	48	46	43	41	38	37	35	33	
70	95	85	77	70	64	60	55	51	48	45	43	40	38	36	35	33	
72	94	85	77	70	64	59	55	51	48	45	42	40	38	36	34	33	
74	94	84	76	69	64	59	55	51	48	45	42	40	38	36	34	33	
76	93	84	76	69	63	59	54	51	47	45	42	40	38	36	34	32	
78	93	83	75	69	63	58	54	50	47	44	42	39	37	36	34	32	
80	92	83	75	68	63	58	54	50	47	44	42	39	37	35	34	32	



Aconselhamento no âmbito da PrEP

Aconselhamento para reforço da prevenção

- Certificar - se da percepção do risco e importância da redução do risco por parte do utente.
- Promover o uso de lubrificantes e do preservativo de forma correcta e consistente e oferta dos mesmos.
- Aconselhamento e referência para os serviços de CMMV, tratamento de ITS e PrEP.
- Reforçar informação sobre o uso do preservativo e métodos de PF, visto que a PrEP não previne contra ITS e gravidez.
- Discutir aspectos de saúde sexual e reprodutiva (**intenções de concepção, concepção segura**).

Aconselhamento antes de iniciar a PrEP

- Certificação da percepção do utente sobre as vantagens da PrEP (falar da diferença entre PrEP, PPE e TARV).
- Identificar factores de risco e barreiras para adesão a PrEP e apoiar na resolução dos mesmos (ex. violência pelo parceiro íntimo, VBG , estigma).
- Informar sobre a importancia da toma das doses recomendadas para a eficácia da PrEP.
- Orientar sobre o que fazer em caso de esquecimento de uma toma.
- Importância da adesão e monitoria continua enquanto estiver a tomar a PrEP.
- Discussão sobre efeitos colaterais dos medicamentos e o que fazer no caso de surgimento.

Regimes de ARVs para a oferta da PrEP

- Em Moçambique, recomenda-se o uso dos seguintes regimes para a PrEP.

Regime	Apresentação	Posologia	Interacções
TDF/3TC (Regime Preferencial)	TDF 300mg/3TC 300mg	1 Comprimido por dia	Administrar com ou sem alimentos Sem interacção descrita com outros ARV, contraceptivos, drogas recreacionais ou álcool
TDF/FTC (Regime Alternativo)	TDF 300 mg/FTC200mg	1 Comprimido por dia	

Contraindicações

- Hipersensibilidade a algum dos medicamentos usados para a PrEP.
- Hipertensão arterial ou diabetes não controladas.
- Patologia renal crónica.
- Depuração da creatinina estimada: $< 60\text{ml/min}$.

- A PrEP é segura, sem efeitos colaterais em 90% dos usuários.
- Utentes em PrEP podem apresentar **efeitos colaterais leves**:
 - Cefaleia, tonturas, diarreia, náusea, redução do apetite, cólicas abdominais e flatulência.
- Geralmente surgem nos primeiros dias ou semanas do uso da PrEP são de curta duração e se resolvem em menos de 1 mês após início da PrEP **sem necessidade de suspender a profilaxia**.
- Em alguns utentes pode se verificar a **elevação da creatinina** que é reversível com a suspensão da PrEP.

Efeitos adversos não são esperados com a PrEP.

- Caso se verifiquem **efeitos adversos** como a **hepatotoxicidade** ou **nefrotoxicidade**, a PrEP deverá ser **interrompida** e estes deverão ser reportados através da ficha de farmacovigilância.



República de Moçambique
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO
SECTOR DE FARMACOVIGILÂNCIA

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE REACÇÕES ADVERSAS AOS MEDICAMENTOS E VACINAS



☐ Informação inicial		☐ Informação complementar	
☐ Unidade Sanitária de Referência Nome: _____		☐ Público	Localidade/Comunidade: _____
		☐ Privado	Distrito _____
			Provincia _____
Iniciais do doente	Idade _____ (anos/meses/dias)	Sexo: F ☐ M ☐	Gravida? ☐ Sim ☐ Não
NID			Mês de grávidas (meses) _____
Breve descrição da reacção adversa			
Burbulhas ☐ Ferimentos ☐ Queimaduras ☐ Cor vermelha na pele ☐			
Outros ☐ _____			
Data de início da reacção/...../.....		Duração da reacção:..... dias/horas	
Data de aplicação da vacina / /			
Insira o(s) medicamento(s) / vacina(s) administrados			

Nome do medicamento/ Vacina	Comprimido, Xarope, Injecção ou Vacina	Quantas vezes tomou 1ª, 2ª, 3ª	Via de Administração o / local	Duração do Tratamento feito (Início Término	Indicação para uso do	Nº de lote / validade
					:.....	

Manejo de efeitos colaterais (1)

Sintoma	Medicamentos	Passos a seguir
Náuseas (enjoo) ou vômitos	Medicação anti náusea	• Evitar alimentos oleosos ou picantes • Comer alimentos secos como torradas • Beber um chá preto • Beber água com limão • Tomar PrEP oral com alimentos • Beber muita água
Diarreia (estômago a correr)	Medicamentos antidiarreicos	• Comer bananas muito maduras • Evitar leite • Beber água que contém sal e açúcar
Dor de cabeça	Analgésicos	• Beber muita água • Deitar-se e coloque um pano frio sobre o rosto • Massajar a base do crânio com os polegares

Manejo de efeitos colaterais (2)

Sintoma	Medicamentos	Passos a seguir
Erupção cutânea	Anti-histamínicos	• Usar um creme calmante natural, loção de calamina ou óleo de rícino
Perda de apetite		• Comer pequenas refeições regularmente • Comer os alimentos de que gosta mesmo que não tenha fome • Evitar os alimentos que não têm qualquer valor nutricional
Tonturas		• Tome os seus comprimidos antes de dormir e quando esteja deitado.
Cansaço		• Ver se há algo mais que cause cansaço, por exemplo, falta de sono, demasiado álcool • Tente tomar os seus comprimidos antes de dormir

Consultas de Seguimento da PrEP (1)

Reavaliação do perfil
de risco/elegibilidade

Promoção e oferta de
preservativos,
lubrificantes, rastreio
de VBG

Rastreio e tratamento
de ITS/ Sífilis

Entrega de
medicamentos
TDF/3TC
Marcar a data da
Próxima consulta

Reforço da
conselhamento para
adesão e
cumprimento do
calendário de visitas

Avaliação para o
despiste de doença
renal e ou solicitação
de creatinina sérica
onde aplicável

Consultas de Seguimento da PrEP (2)

- Os utentes em PrEP oral requerem visitas de seguimento com o provedor de saúde.
- A frequência óptima de visitas para monitorizar a utilização da PrEP oral em Moçambique é:
 - 1ª consulta de seguimento : um mês após a consulta inicial
 - 2ª consulta de seguimento : 2 meses após a 1ª consulta de seguimento
 - A partir da 2ª consulta : seguimento a cada 3 meses.
- Fora das visitas de monitoria regulares, os utentes devem também comunicar se tiverem efeitos colaterais assim como sinais e sintomas de doença.

Cronograma de avaliação clínica e laboratorial de utentes em PrEP

Avaliação clínica e laboratorial	Consulta inicial	Consultas de seguimento (meses)											
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
Avaliação da elegibilidade e de factores de risco	X	X		X			X			X			X
Aconselhamento e testagem para o HIV	X			X			X			X			X
Avaliação da infecção aguda pelo HIV	X	X		X			X			X			X
Rastreio e tratamento de ITS/Sífilis	X	X		X			X			X			X
Avaliação para o despiste de doença renal	X	X		X			X			X			X
Solicitação de creatinina sérica	X						X						X
Promoção e oferta de preservativos, lubrificantes, rastreio de VBG	X			X			X			X			X
Reforço do aconselhamento para adesão	X	X		X			X			X			X
Dispensa dos medicamentos (número de comprimidos)	30	60		90			90			90			90

- Reforçando as mensagens de aconselhamento em todas as consultas de seguimento.
- Educação por pares.
- Apoio para o cumprimento do calendário das consultas, levantamento da PrEP e reforço da adesão através de chamadas de lembrete antes de cada consulta.
- Inclusão em modelos diferenciados de oferta da PrEP:
 - Paragem única.
 - Dispensa trimestral a partir da segunda consulta de seguimento.
 - Brigada Móvel.
 - Clínica Móvel para População-chave.
 - Centros Comunitários de redução de danos para PID.

Reforço da adesão e continuidade em PrEP (2)

Guião de Aconselhamento de seguimento

As sessões de acompanhamento provavelmente serão breves. É fundamental rever a adesão durante essas sessões e reavaliar o perfil de risco do paciente, caso ele tenha experimentado mudanças no estilo de vida. Certifique-se de que utiliza as ferramentas de aconselhamento disponíveis na sua organização para cada um destes tópicos.



Conselheiros comunitários

O QUE ABORDAR:	COMO ABORDAR:
Re-avaliar o perfil de risco do paciente	Discuta quaisquer mudanças no estilo de vida que possam afectar a adequação do uso da PrEP
Prevenção combinada	Aborde com base no plano de saúde sexual da pessoa e verifique se ela tem acesso a outros recursos de prevenção, conforme apropriado.
Infecção de Transmissão Sexual (ITS)	A PrEP não protege contra ITS. São encorajados Testes regulares para ITS, independentemente do uso da PrEP. IMPORTANTE: Se o seu paciente se apresentar com uma ITS, ele precisará de aconselhamento adicional.
Contracepção	A PrEP é segura quando usada com todos os métodos contraceptivos. Consulte um médico para fornecer orientação sobre como proceder se a mulher estiver grávida.
Adesão	Para que a PrEP seja eficaz, o comprimido deve ser tomado todos os dias. O aconselhamento de adesão é fundamental para a protecção total do HIV.
Efeitos Colaterais	Aborde com base na experiência da pessoa com efeitos colaterais. LEMBRE-SE: Se os efeitos colaterais forem sérios, envolva um médico para cuidados.
Violência	As pessoas que têm parceiros violentos podem ter dificuldades de cuidar da sua saúde sexual e aderir à PrEP. Aborde sobre o relacionamento da pessoa e forneça aconselhamento e referências quando necessário.
Falando com seu parceiro, família, amigos, etc.	A decisão de revelar sobre o uso de PrEP é completamente pessoal. Algumas pessoas acham útil contar à amigos ou familiares para lembrar de tomar diariamente os comprimidos. Fale com o paciente sobre a revelação aos seus entes queridos e como superar quaisquer barreiras.
Plano de visitas	Explique o cronograma de visitas durante o uso da PrEP. A pessoa deve retornar para visitas de acompanhamento no primeiro mês e, depois, a cada três meses. Ela também deve retornar à Unidade Sanitária mensalmente para levantar os comprimidos.

A Adesão é fundamental para obter protecção contra o HIV
Sugerir alguns métodos para a pessoa lembrar de tomar o comprimido todos os dias.

Por exemplo:

- Tomar o comprimido na mesma hora todos os dias
- Incluir a toma do comprimido na sua rotina diária, isto é, como parte da sua rotina matinal ou quando iniciar a escuta da Rádio
- Activar o alarme do telefone à hora da toma do medicamento
- Pedir aos membros da família ou amigos para lhe lembrar de tomar o medicamento
- Usar a caixinha com arrumação diária
- Discutir o que fazer em caso de se esquecer de tomar o comprimido - oriente para toma logo que se lembrar.

Em caso de dúvidas
liga grátis para os números:

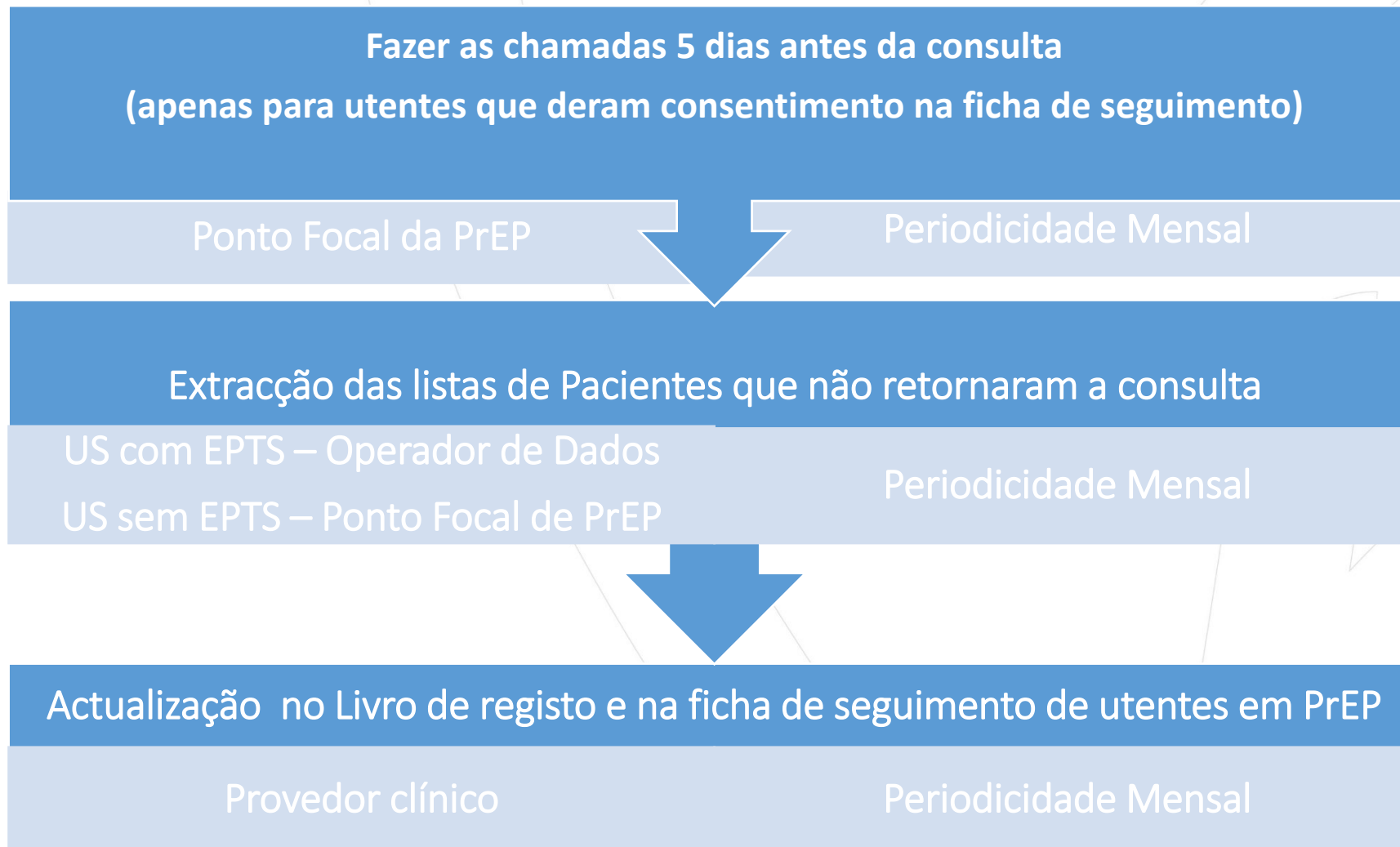


A PrEP esta só está disponível em algumas Unidades Sanitárias, mediante recomendação do profissional de saúde.

É importante o reforço de aconselhamento de adesão a PrEP pelo “Provedor Clínico “ integrado em cada consulta

Reforço da adesão e continuidade em PrEP (3)

Fluxo de identificação e seguimento de utentes que não retornam as consultas



Ao iniciar a PrEP

- Após início da PrEP, existe um tempo necessário para que o medicamento que circula no sangue e outros tecidos atinjam níveis adequados de protecção contra o HIV:
 - Mínimo de 7 dias após o início da PrEP no caso de relação sexual anal.
 - Mínimo de 20 dias após o início da PrEP para relação sexual vaginal.

Atenção!

Durante esse período, é crucial, o uso correcto e persistente do preservativo em todas as relações sexuais.

Descontinuidade ou interrupção da PrEP :

- Seroconversão ao longo do seguimento (Teste positivo para HIV).
- Teste de HIV Indeterminado (seguimento do protocolo de testagem)
- A pedido do utente (preferência do utente).
- Contra-indicações para a PrEP (ex. lesão renal - depuração de creatinina <60 mL/min).
- Ausência de factores de risco após a avaliação de risco nas consultas subsequentes.
- Presença de sinais/sintomas de infecção aguda pelo HIV.
- Utente não pertence ao grupo-alvo.

Atenção!

- A PrEP deve ser interrompida durante os períodos de ausência de risco, pois o utente deixa de ser elegível a PrEP.

Caso o utente decida parar de tomar a PrEP oral:

- Explorar com o utente estratégias de prevenção/riscos alternativos e de redução de riscos.
- Aconselhar o utente que será necessário um teste de HIV para reiniciar a PrEP oral.
- Explicar que a PrEP oral precisa de ser mantida durante 28 dias após a última exposição ao HIV, devido ao risco de contrair a infecção pelo HIV.

Considerações durante a avaliação clínica de utentes em PrEP (4)

Atenção!

O que temos de considerar para utentes que param e iniciam várias vezes?

- A PrEP não é uma intervenção para toda a vida.
- A PrEP pode parar de acordo com o período de exposição dos utentes ao risco.
- Os provedor de saúde devem discutir a exposição ao risco com os utentes para garantir que o estão a fazer correctamente.

- Necessidade de 7 dias de dosagem diária da PrEP oral para atingir níveis de protecção adequados.
- Durante este período, devem ser utilizadas outras precauções de protecção, tais como a abstinência ou preservativos.
- Os medicamentos da PrEP oral devem ser continuados durante 28 dias após a última exposição potencial ao HIV naqueles que desejem abandonar o ciclo da PrEP oral.

Transição da Profilaxia Pós-Exposição para Profilaxia Pré-Exposição :

- Recomenda-se a transição de PPE para PrEP caso o utente reporte 3 ou mais exposições num período de 1 ano.
- Esta transição deve ocorrer imediatamente após o término da PPE, ou seja após 28 dias de PPE.
- Antes da transição deve ser feito o teste de HIV, que deve ser negativo.
- Deve-se fazer a re-testagem na sexta semana de seguimento.

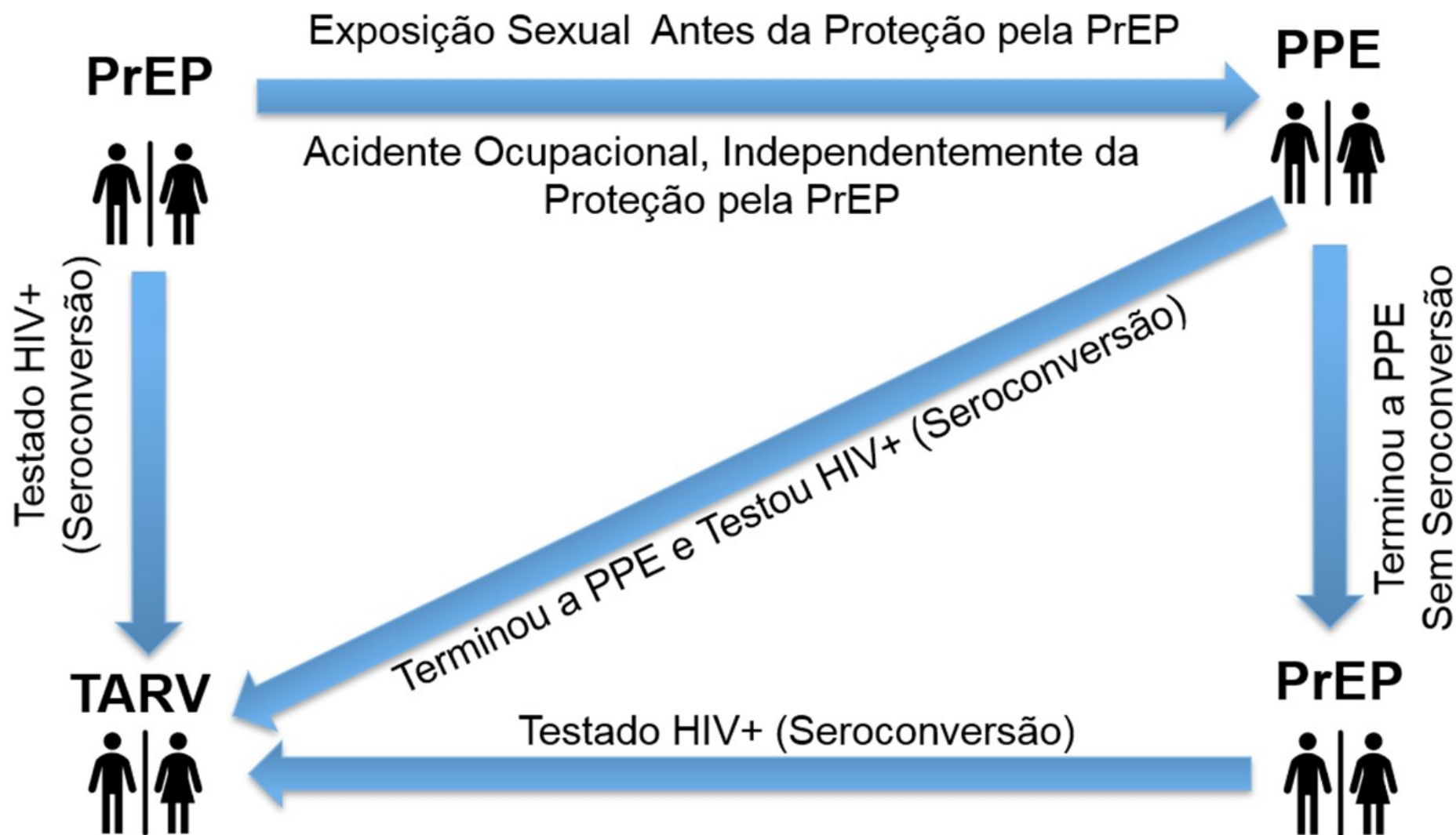
Atenção!

A transição imediata diminui o risco de aquisição da infecção pelo HIV

Transição da Profilaxia Pré-Exposição para o tratamento antirretroviral devido a seroconversão:

- A seroconversão do estado de HIV pode ocorrer após a oferta da PrEP e nestes casos o paciente deve ser referido para os serviços TARV para início imediato do tratamento.
- A transição imediata da PrEP para o TARV poderá evitar o risco de aumento da carga viral e possibilidade de transmissão.

Transição entre PPE, PrEP e TARV





***Dúvidas!
Comentários!***

Pontos-Chave

- Todos os provedores devem ser capacitados de acordo com as suas competências no pacote completo de intervenções para oferta desta abordagem e devem oferecer a PrEP seguindo a escala de rotatividade elaborada pela US.
- Em cada consulta deve-se garantir o rastreio de ITS, Infecção aguda pelo HIV e avaliação da função renal.
- O regime recomendado para a PrEP em Moçambique é o TDF/3TC.
- Após início da PrEP, existe um tempo necessário para que o medicamento que circula no sangue e outros tecidos atinjam níveis adequados de protecção contra o HIV, mínimo de 7 dias após o início da PrEP no caso de relação sexual anal e 20 dias após o início da PrEP para relação sexual vaginal.

Pontos-Chave

- A PrEP só é eficaz quando tomada diariamente enquanto persistirem os factores de risco.
- A PrEP pode ser interrompida durante períodos de ausência de risco, pois o utente deixa de ser elegível a PrEP, podendo ser retomada sempre que houver risco de se contrair o HIV.
- No momento de se descontinuar a PrEP, atenção a necessidades de ser mantida durante 28 dias após a última exposição ao HIV, devido ao risco de contrair a infecção pelo HIV.
- Em casos de seroconversão do estado de HIV após a oferta da PrEP, o paciente deve ser referido para os serviços TARV para início imediato do tratamento.